

ETILISTA — TIAMINA ANTES DA GLICOSE

OS DISTÚRBIOS METABÓLICOS DO ETILISTA

Quadro	Mecanismo	Achado típico
Hipoglicemia alcoólica	Álcool inibe a gliconeogênese; jejum esgota o glicogênio	Glicemia baixa, rebaixamento, pode ser fatal
Cetoacidose alcoólica (CAA)	Jejum + álcool: lipólise e cetogênese, com glicemia normal/baixa	Acidose com GAP alto, cetose, glicemia geralmente < 250
Encefalopatia de Wernicke	Deficiência de tiamina	Confusão + oftalmoplegia + ataxia
Acidose láctica	Hipoperfusão, tiamina baixa, sepse	Lactato elevado
Distúrbios eletrolíticos	Perdas e desnutrição	HipoK, hipoMg, hipofosfatemia, hiponatremia
Hiperglicemia (DM associado)	Etilista também pode ter diabetes/pancreatite	Glicemia alta — distinguir de CAD

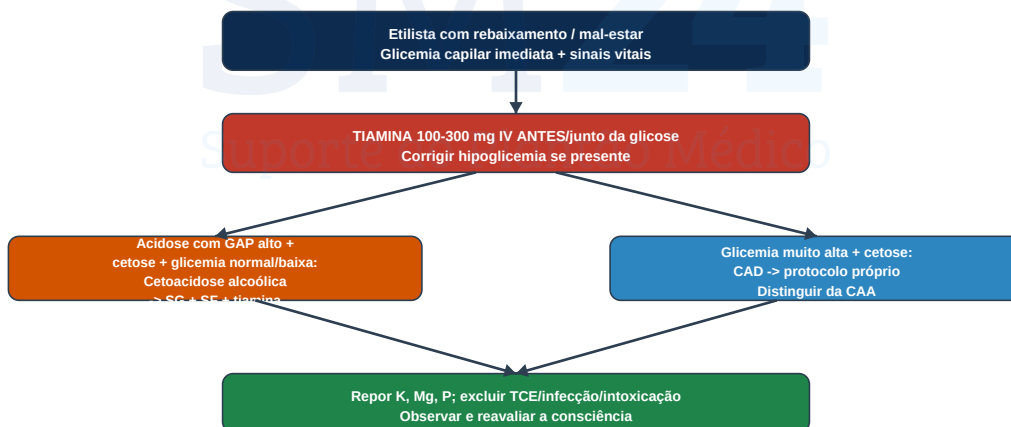
REGRA DE OURO NO ETILISTA REBAIXADO

TIAMINA ANTES (OU JUNTO) DA GLICOSE

- Sempre administrar TIAMINA antes ou junto da glicose no etilista — glicose isolada pode precipitar Wernicke
- Glicemia capilar imediata em todo etilista com rebaixamento (hipoglicemia é causa comum e reversível)
- Hipoglicemia: corrigir com glicose IV (após/junto da tiamina) e reavaliar
- Não atribuir o rebaixamento à embriaguez sem checar glicemia, eletrólitos e excluir TCE/infecção
- Repor magnésio e potássio (frequentemente baixos e dificultam outras correções)
- Considerar TCE oculto, hematoma subdural, intoxicações associadas e sepse

ABORDAGEM DO ETILISTA COM ALTERAÇÃO DA CONSCIÊNCIA

ETILISTA REBAIXADO — METABÓLICO ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO



CETOACIDOSE ALCOÓLICA vs CETOACIDOSE DIABÉTICA

Aspecto	Cetoacidose alcoólica	Cetoacidose diabética
Glicemia	Normal ou baixa (geralmente < 250)	Alta (> 250)
Contexto	Etilista, jejum, vômitos, parada de ingestão	Diabético, infecção, omissão de insulina
Tratamento base	Soro glicosado + salina + TIAMINA	Insulina + salina + potássio
Insulina	Geralmente NÃO necessária	Pilar do tratamento
Cetose	Predomínio de beta-hidroxibutirato	Cetose com GAP alto
Resposta	Melhora rápida com glicose e volume	Requer protocolo de insulina

TRATAMENTO E ARMADILHAS

Cetoacidose Alcoólica

- Soro glicosado 5-10% + salina 0,9% (volume) — a glicose freia a cetogênese
- Tiamina antes da glicose (prevenir Wernicke)
- Repor potássio, magnésio e fósforo
- Insulina geralmente NÃO é necessária (glicemia normal/baixa)
- Tratar causa associada (pancreatite, infecção, sangramento)
- Melhora costuma ser rápida em 12-24h

Não Esquecer no Etilista

- Hipoglicemia pode recorrer — reavaliar a glicemia
- Magnésio baixo dificulta a correção de potássio e cálcio
- Excluir TCE/hematoma subdural (queda, alteração desproporcional)
- Síndrome de abstinência alcoólica pode coexistir
- Intoxicação por metanol/etilenoglicol: GAP osmolar e acidose grave
- Pancreatite e hepatopatia frequentemente associadas

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Glicemia capilar imediata em todo etilista sintomático
- ☐ Tiamina antes/junto da glicose (prevenir Wernicke)
- ☐ Diferenciar hipoglicemia, cetoacidose alcoólica e cetoacidose diabética
- ☐ CAA: soro glicosado + salina + tiamina; insulina geralmente desnecessária
- ☐ Repor potássio, magnésio e fósforo; vigiar recorrência de hipoglicemia
- ☐ Excluir TCE, infecção, pancreatite e outras intoxicações

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Etilista crônico chega rebaixado. Qual deve ser a sequência correta de tratamento?

- A) Glicose hipertônica isolada imediata
- B) Tiamina antes (ou junto) da glicose, após checar a glicemia capilar
- C) Apenas observação até passar o efeito do álcool
- D) Naloxona em dose alta
- E) Insulina regular IV

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente etilista, em jejum, com acidose metabólica de ânion-gap elevado, cetose e glicemia de 90 mg/dL. Qual o diagnóstico e o tratamento de base?

- A) Cetoacidose diabética — insulina em bomba
- B) Cetoacidose alcoólica — soro glicosado + salina + tiamina
- C) Acidose láctica isolada — bicarbonato
- D) Insuficiência renal — diálise
- E) Intoxicação por salicilato — alcalinização

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Por que o álcool causa hipoglicemia em jejum prolongado?

- A) Porque aumenta a secreção de insulina
- B) Porque inibe a gliconeogênese hepática, e o jejum já esgotou as reservas de glicogênio
- C) Porque bloqueia a absorção intestinal de glicose
- D) Porque estimula a captação muscular de glicose
- E) Porque inibe o glucagon exclusivamente

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Na cetoacidose alcoólica, qual afirmação sobre a insulina é correta?

- A) A insulina é o pilar do tratamento, como na CAD
- B) A insulina geralmente NÃO é necessária, pois a glicemia costuma estar normal ou baixa
- C) A insulina deve ser administrada em dose dobrada
- D) A insulina deve ser dada por via oral
- E) A insulina deve ser associada a glucagon

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual eletrólito frequentemente baixo no etilista dificulta a correção de potássio e cálcio?

- A) Sódio
- B) Magnésio
- C) Cloro
- D) Bicarbonato
- E) Fósforo apenas

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

No etilista rebaixado, deve-se checar a glicemia capilar e administrar TIAMINA antes (ou junto) da glicose, pois a glicose isolada pode precipitar a encefalopatia de Wernicke em paciente deficiente de tiamina.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Acidose com GAP elevado + cetose + glicemia normal/baixa em etilista em jejum caracteriza a cetoacidose alcoólica. O tratamento de base é soro glicosado + salina + tiamina; a insulina geralmente não é necessária.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O álcool inibe a gliconeogênese hepática. Em jejum prolongado, com as reservas de glicogênio já esgotadas, a manutenção da glicemia depende da gliconeogênese — daí a hipoglicemia, que pode ser grave.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Na cetoacidose alcoólica a glicemia costuma estar normal ou baixa, e a cetogênese é revertida com a oferta de glicose e volume. Por isso a insulina geralmente NÃO é necessária (diferente da CAD).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O magnésio frequentemente está baixo no etilista (perdas e desnutrição) e a hipomagnesemia dificulta a correção de potássio e cálcio. Deve ser repostado para que as demais correções sejam efetivas.

SM24
Suporte ao Plantão Médico